Клинические рекомендации

Химический ожог пищевода

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T28.5** — Химический ожог рта и глотки **T28.6** — Химический ожог пищевода **T28.7** — Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Региональная Общественная организация "Национальное общество Торакальных Хирургов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/821_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и осмотр 5

3.2 Анализы 5

3.3 ЭГДС 6

3.4 Рентгенологическое исследование 6

3.5 КТ 7

4. Лечение 7

4.1 Острая стадия: неотложная помощь 7

4.2 Острая стадия: кровотечения, инфекция, питание 8

4.3 Острая стадия: перфорация 8

4.4 Формирующиеся стриктуры (до 4 недель) 9

4.5 Сформированные стриктуры 9

4.6 Реконструктивные операции 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Показания к госпитализации 11
5.2 Реабилитация 11
5.3 Диспансерное наблюдение 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Химический ожог пищевода — местное повреждение стенки пищевода веществом прижигающего действия, принятым внутрь; ожог ЖКТ сопровождается токсическим резорбтивным действием.
- В приёмном отделении — оториноларинголог (вовлечение дыхательных путей) и токсиколог. Отёк и угроза асфиксии — интубация, невозможна — трахеостомия. **Отсутствие ожога рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.
- ЭГДС — **в первые 12–48 часов**, батарейка и кристаллы перманганата калия — экстренно; степень — по Zargar. Взрослым — экстренная КТ с контрастом.
- Нельзя: промывать желудок без зонда с вызыванием рвоты, давать нейтрализаторы.
- Рубцы формируются за **4–6 недель**; стриктуры лечат бужированием (до 12, максимум 24 месяцев), при неэффективности — пластика пищевода. Наблюдение хирурга **3 года**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Химический ожог пищевода — местное повреждение стенки пищевода при случайном или преднамеренном приёме внутрь химического вещества прижигающего действия. Химический ожог ЖКТ — повреждение полости рта, глотки, пищевода, желудка; сопровождается токсическим резорбтивным действием.

Послеожоговый стеноз пищевода — сужение просвета и деформация стенки пищевода разной протяжённости на разных уровнях за счёт рубцовой ткани в месте воздействия.

2.2 Этиология

1. **щелочи** — моющие средства, средства для прочистки труб, электролит батареек; колликвационный некроз, глубокое поражение до трансмурального некроза и перфорации
2. **кислоты** — консерванты, отбеливатели, средства от накипи; коагуляционный некроз, всасывание токсина в кровоток
3. **сильные окислители** — перманганат калия, перекись водорода; кристаллы перманганата калия поражают и глотку, надгортанник, голосовые складки
4. **дисковые батарейки (у детей)** — электролиз с образованием щелочи и кислоты, утечка электролита, пролежень, непроходимость пищевода

Дети чаще всего в 1–3 года (80,3%), прием непреднамеренный; подростки — чаще с суицидальной целью. У взрослых — чаще в 30–40 лет, в 85–87% в алкогольном опьянении по ошибке; у женщин преобладают суицидальные попытки. Приём залпом 50–100 мл и более — глубокие ожоги рта, глотки, пищевода, желудка и кишки, гибель в первые 2–3 суток.

2.3 Классификация

1. **по этиологии** — кислоты, щелочи, прочие
2. **по глубине** — I — катаральное поражение; II — эрозивное, не глубже мышечной пластинки слизистой; III — язвенное поражение слизистой и подслизистого слоя; IV — язвенно-некротическое со слизистым, подслизистым и мышечным слоями
3. **по времени развития непроходимости** — ранняя (**до 3–4 недель**), поздняя (позже 1 месяца)
4. **по стадиям** — острая (токсикогенная); отторжения некротических тканей; формирования рубцовых изменений; отдалённые сроки

1. **по степени сужения** — 1 — избирательная, 1,0–1,5 см, не проходит грубая пища; 2 — компенсированная, 0,3–0,5 см, проходит полужидкая пища; 3 — субкомпенсированная, меньше 0,3 см, проходит только жидкость; 4 — обратимая полная непроходимость; 5 — полная облитерация
2. **по протяжённости** — короткие (мембранозные), циркулярные до 3 см, трубчатые более 3 см, чёткообразные, тотальное поражение
3. **по локализации** — высокие (вход в пищевод, шейный отдел), срединные, низкие (кардиальные), комбинированные
4. **по осложнениям** — ложные дивертикулы, ложные ходы, рубцовое укорочение, свищи (пищеводно-бронхиальные, пищеводно-трахеальные)
5. **по сочетанности** — изолированный ожог пищевода; сочетанный с ожогом желудка или ДПК

Эндоскопическая классификация Zargar S. A.

Степень	Эндоскопическая картина
0	нормальная слизистая оболочка
I	отёк и эритема слизистой
IIA	кровоизлияния, эрозии, волдыри, поверхностные язвы
IIB	глубокие и циркулярные язвы
IIIA	очаговые тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IIIB	обширные тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IV	перфорация

2.4 Клиническая картина

Острая токсикогенная стадия (**первые 3–7 суток**). **Отсутствие ожога полости рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.

Сразу после приёма

1. боль, дисфагия;
2. осиплость голоса;
3. гиперсаливация; у детей — резкое беспокойство;
4. возможна фебрильная лихорадка;
5. ожоги лица, шеи, груди.

Системные синдромы

1. экзотоксический шок;
2. дыхательная недостаточность — аспирация, пневмония, отёк и стеноз гортани;
3. гемолиз и нефропатия (особенно уксусная кислота), метаболический ацидоз; при щелочах — алкалоз;
4. токсическая коагулопатия до ДВС-синдрома, гепатопатия.

При обширных ожогах III–IV степени без лечения пациенты погибают в первые 1–2 суток.

Стадия отторжения некротических масс, или мнимого благополучия (**1–3 неделя**): уменьшаются отёк и слюнотечение, нормализуется температура, пациент начинает есть. **Нельзя выписывать с неустановленной степенью ожога**. При тяжёлых ожогах и осложнениях этой стадии может не быть.

Токсикологи выделяют соматогенную стадию (первые 2 недели): ранние осложнения (1–2 сутки) — механическая асфиксия при ожоге рта и верхних дыхательных путей, делирий, панкреатит; поздние (после 3 суток) — трахеобронхит, пневмония, психоз.

Стадия формирования рубцов (**4–6 недель**).

Проявления

1. нарастающая дисфагия — обычно к концу 3-й недели, сначала для твёрдой пищи, затем для жидкой;
2. пищеводная рвота без кислого запаха;
3. потеря массы тела.

Через **15–20 лет** в рубцах и над стенозом нередко развивается плоскоклеточный рак.

Дисковая батарейка и кристаллы перманганата калия у детей: острая стадия длится не более суток. При перманганате слизистая рта окрашена в тёмно-фиолетовый цвет. Мнимого благополучия часто нет, нераспознанный ожог похож на бронхит или пневмонию.

Острая стадия

1. гиперсаливация, дисфагия;
2. беспокойство, отказ от питья и еды.

Осложнения

1. батарейка — стеноз пищевода, парез гортани, перфорация, медиастинит, трахеопищеводный и аортопищеводный свищ;
2. перманганат калия — стеноз глотки, стеноз гортани.

---

3. Диагностика

Диагноз — по анамнезу (приём химического вещества внутрь), жалобам, осмотру (ожог лица и полости рта, специфический запах) и инструментальным данным.

3.1 Жалобы и осмотр

Жалобы: боль во рту, за грудиной и в эпигастрии, боль при глотании, дисфагия, слюнотечение, осиплость, рвота.

Следы ожога на подбородке и в углах рта, состояние слизистой полости рта, пульс, артериальное давление.

Острая стадия: беспокойство, бледность, при тяжёлом отравлении — акроцианоз; отёк и гиперемия языка, щёк, язычка, дужек, некрозы в виде серых, жёлтых или чёрных плёнок; запах уксуса, формалина, нашатырного спирта; тахикардия. Экзотоксический шок — одышка, холодный пот, нитевидный пульс, гипотония. Ожог желудка — защитное напряжение мышц, затем симптомы раздражения брюшины; кровь в рвотных массах.

В приёмном отделении — оториноларинголог (вовлечение начальных отделов дыхательных путей) и токсиколог (при его отсутствии — реаниматолог).

3.2 Анализы

Всем

1. развёрнутый общий анализ крови, общий анализ мочи;
2. биохимия: билирубин и фракции, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза, натрий, калий, хлориды, кальций.

Нефропатия, гепатопатия, почечно-печёночная недостаточность — дополнительно амилаза, ЩФ, ГГТ, общий белок, альбумин.

Отравление уксусной кислотой — свободный гемоглобин в плазме и моче: лёгкий гемолиз — **5 г/л**, средний — 5–10 г/л, тяжёлый — **более 10 г/л**.

3.3 ЭГДС

Боль в острой фазе — перед эндоскопией анальгетики и спазмолитики (папаверин и производные).

ЭГДС — оценка распространённости и глубины поражения; обычно **в первые 12–48 часов**, безопасна до 96 часов. Батарейка или кристаллы перманганата калия — **экстренно**.

При минимальных проявлениях — в ближайшее время, при тяжёлых — после стабилизации. В 5–15 дней эндоскопия опасна перфорацией истончённой стенки. Экстренная эндоскопия нужна, если нельзя выполнить КТ (нет аппарата, противопоказан контраст, дети, сомнительная КТ).

Диагностическая ЭГДС не рекомендуется до стабилизации

1. нестабильная гемодинамика;
2. рентгенологические признаки перфорации пищевода и медиастинита;
3. ожог надгортанника с отёком, ожог гортани и глотки III степени;
4. ожог дыхательных путей, требующий интубации или трахеостомии.

Ожог надгортанника, гортани и глотки грозит асфиксией из-за отёка голосовых складок, особенно при ожоге кристаллами перманганата калия.

Степень ожога и прогноз — по классификации Zargar.

В первые сутки при ожоге I–II степени — белесые коагуляционные плёнки по рельефу складок; некроз тёмно-коричневый или чёрный; при отторжении струпа (3–4 сутки) — тёмно-красные грануляции.

Ожог I степени, стабильное состояние без жалоб — контрольная ЭГДС **не рекомендуется**.

Ожог II–III степени, стабильное состояние без жалоб — контрольная ЭГДС **через 4–6 недель**.

Альтернатива — эндоскопическая классификация Волкова (1997) в дополнении Песни-Прасоловой (2006).

Стадия грануляций и рубцов — ЭГДС **через 3 недели** после травмы: локализация и протяжённость стеноза, показания к бужированию, баллонной дилатации, стентированию.

Эндоскопическая классификация рубцовых стенозов пищевода (Галлингер, 2000)

Степень	Просвет в зоне сужения
I	9–11 мм, проходит среднекалиберный гастроскоп
II	6–8 мм, проходит бронхофиброскоп 5,5–7 мм
III	3–5 мм, проходит ультратонкий эндоскоп 2,4–2,8 мм
IV	1–2 мм или просвета нет, проходит только струна

Дисфагия — начинать со среднекалиберного эндоскопа, чтобы не пропустить рубцы ротоглотки и входа в пищевод; затем малокалиберные эндоскопы. При подозрении на рак — биопсия.

3.4 Рентгенологическое исследование

Обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости: воздух в средостении — перфорация пищевода, под диафрагмой — перфорация желудка.

Рентгеноконтрастное исследование пищевода: распространённость и глубина поражения пищевода и желудка. Перфорация — водорастворимый йодсодержащий контраст; поздние исследования — бария сульфат.

1. **I степень** — глотание свободное, просвет обычный, складки местами утолщены до 5 мм, перистальтика сохранена
2. **II степень** — глотание болезненное, просвет сужен, складки сглажены, стенка неэластична, не перистальтирует, спазмы, регургитация
3. **III–IV степень** — глотание резко болезненное, просвет расширен до 4–6 см с жидкостью, атония, рельефа нет, плоские ниши

Стадия рубцов — рентгенография пищевода с обязательным исследованием желудка и ДПК: локализация, протяжённость, диаметр стриктур. Непроходимость пищевода или свищ — водорастворимый контраст.

Экзотоксический шок, нарушение глотания и проходимости пищевода — контрастное исследование **не рекомендуется**: аспирация.

3.5 КТ

18 лет и старше — экстренная КТ грудной и брюшной полости с внутривенным контрастом (при сохранной функции почек): локализация, объём и глубина поражения.

КТ точнее ранней эндоскопии оценивает трансмуральный некроз; решение об экстренной экстирпации пищевода основывают на КТ-признаках трансмурального некроза. Прогноз по КТ: I степень — осложнения маловероятны; II — возможна стриктура; III — стриктура неизбежна; IV — трансмуральное поражение, высокий риск перфорации, неотложная эзофагэктомия. Эндоскопию в первые 12–48 часов КТ полностью не заменяет.

Дети — рутинная КТ не рекомендуется (нет данных, лучевая нагрузка); полезна при обширном поражении перед операцией.

Высокий риск перфорации желудка по эндоскопии — диагностическая лапароскопия: исключить перитонит.

---

4. Лечение

4.1 Острая стадия: неотложная помощь

Немедленное комплексное лечение: обезболивание, промывание желудка через зонд, местное лечение, детоксикация с коррекцией нарушений органов. Ожог кристаллами перманганата калия — растворы слабых кислот (аскорбиновая кислота).

Обезболивание у взрослых: опиоиды (морфин, тримеперидин, кодеин + морфин + носкапин + папаверин + тебаин) или кеторолак, метамизол натрия по 1 мл 3–4 раза в сутки; атропин 0,1% 1 мл 2 раза в сутки; папаверин 2% 2 мл, дротаверин 2 мл в/м или платифиллин 0,2% 1 мл подкожно до 4 раз в сутки; глюкозоновокаиновая смесь (500 мл 5% декстрозы и 50 мл 2% прокаина) в/в 2–3 раза в сутки.

Компенсированный стеноз гортани — глюкокортикоиды внутривенно и ингаляционно, атропин внутривенно. Ожог I степени — без глюкокортикоидов, II–III степени — коротким курсом 5–7 дней.

Промывание желудка без зонда с вызыванием рвоты **не рекомендуется**: повторный ожог пищевода, аспирация. Через зонд — эффективно и безопасно **в первые 2–3 часа**, через 12 часов неэффективно.

Нейтрализаторы при неотложной помощи **не рекомендуются**.

Нарастает отёк дыхательных путей, угроза асфиксии — интубация трахеи; невозможна — трахеостомия.

Экзотоксический шок

1. сбалансированные электролитные растворы, затем растворы декстрозы;
2. при неэффективности — альбумин 5% или 10%;
3. в первые 6 часов — меглюмина натрия сукцинат 1,5% против ацидоза.

Интенсивная терапия шока

1. гидроксиэтилкрахмал противопоказан;
2. сердечная недостаточность — добутамин;
3. ацидоз — 4% натрия гидрокарбонат;
4. целевой диурез — 0,5–1,0 мл/кг/ч.

4.2 Острая стадия: кровотечения, инфекция, питание

Ранние вторичные кровотечения — местный гемостаз (лучше локальная гипотермия пищевода и желудка) и гепарин натрия — только после локальной остановки кровотечения.

Поздние кровотечения — гепарин **не рекомендуется**; стандартная гемостатическая терапия: голод, переливание эритроцитов, плазмы, фибриногена.

Профилактика поздних кровотечений — ингибиторы протонного насоса и антациды.

Поздние кровотечения — эндоскопический гемостаз (электро- или лазерная коагуляция).

Взрослые — антикоагулянты для лечения токсической коагулопатии и профилактики микротромбов, под контролем свёртывания, фибриногена, тромбоцитов.

Профилактика инфекционных осложнений — антибиотики широкого спектра, затем по результатам посева.

Ранняя нутритивная поддержка — **в первые 12 часов**.

1. пища механически, термически и химически щадящая;
2. недостаточно — парентеральное питание вместе с энтеральным;
3. энтеральное невозможно — решить вопрос о гастростоме.

Ингибиторы протонного насоса (в остром периоде — внутривенно), облепиховое масло, антациды.

Профилактика рубцового сужения — глюкокортикоиды

1. **лёгкий ожог** — в стационаре **7 суток**, затем амбулаторно **3 недели**
2. **средней тяжести** — **до 20 суток**, затем **1 месяц**
3. **тяжёлый** — **не менее 30 суток**, затем **до 2 месяцев**

4.3 Острая стадия: перфорация

Перфорация пищевода или желудка — экстренные мероприятия по локализации, размеру перфорации и осложнениям; тактика — по рентгеноскопии с водорастворимым контрастом и (или) КТ.

1. **без медиастинита** — кормление через рот исключают, назогастральный зонд, парентеральное питание, антибиотики (цефалоспорины, метронидазол, защищённые пенициллины), иногда гастростомия
2. **медиастинит** — экстренная операция торакотомным или торакоскопическим доступом: санация и дренирование средостения, гастростома с антирефлюксной операцией; возможна эндоскопическая вакуумная терапия
3. **необратимые изменения пищевода** — эзофагэктомия с эзофаго- и гастростомой; у взрослых — эзофагогастрэктомия, летальность 25–34%

4.4 Формирующиеся стриктуры (до 4 недель)

Выраженная дисфагия и быстро формирующиеся рубцы — профилактическое бужирование пищевода.

Бужи не меньше возрастного размера пищевода, в стационаре **3 раза в неделю** по струне-проводнику, затем прямое бужирование; через 3 недели — ЭГДС. Полная эпителизация — бужирование прекращают, контроль через 2–3 месяца. Ожог III степени — 3 недели по 3 раза в неделю, затем амбулаторно раз в неделю 2–3 месяца, 2 раза в месяц 2–3 месяца, раз в месяц полгода; ЭГДС каждые 3 месяца.

4.5 Сформированные стриктуры

Стриктура, нарушающая питание, — поддерживающее бужирование **12 месяцев**; при стойкой положительной динамике — не более **24 месяцев**. Неэффективно — пересмотреть программу или реконструктивная операция.

Начинать через **4–6 недель** после ожога, по струне-проводнику под эндотрахеальным наркозом: не более 3 бужей за сеанс, повтор через 2–3 дня, затем «вслепую» и амбулаторно раз в неделю 3 месяца. Прекращают при полной эпителизации и просвете **не менее 10–12 мм**. Протяжённые стриктуры после щелочей и кислот, ожог гортаноглотки перманганатом у детей — бужирование за нить через гастростому (у детей при ожоге глотки — бужи № 44–60).

Размеры бужей по шкале Шарьера

Возраст	Размер бужа, Fr
до 6 месяцев	33–36
до 1 года	36–40
1–3 года	40–42
4–7 лет	42–44
8–17 лет	44–46

Бужирование неэффективно

1. не достигается максимальный размер бужа;
2. дисфагия или стеноз возвращаются между бужированиями;
3. не удаётся перейти на более редкое бужирование;
4. после курса нарастает дисфагия.

Хороший результат

1. любая пища без дисфагии;
2. поддерживающее бужирование не нужно;
3. просвет в зоне стеноза **не менее 10–12 мм**.

Стриктура **до 5 см** — альтернатива: гидростатическая баллонная дилатация под рентгеноскопией, под общей анестезией.

Стентирование при формирующихся стриктурах **не рекомендуется**: нет положительных результатов, много осложнений.

4.6 Реконструктивные операции

Показания к операции при послеожоговых стриктурах

1. полная облитерация просвета;
2. извилистый просвет со слепыми карманами и дивертикулами;
3. нельзя провести буж № 28–30 из-за плотных рецидивирующих стриктур;
4. пищеводные свищи;
5. перфорация пищевода в анамнезе;
6. рубцы **более 15 лет** — риск малигнизации;
7. укорочение пищевода с грыжей пищеводного отверстия и рефлюкс-эзофагитом.

Изолированный рубцовый стеноз глотки — пластика глотки свободным сегментом кишки.

Изолированные стенозы глотки в 100% случаев — от кристаллов марганца: рубцуются вход в глотку и в гортань (надгортанник лизируется), выживают только при экстренной трахеостомии; пациенты — с трахео- и гастростомой. Трансплантат реваскуляризируют с общей сонной артерией и внутренней яремной веной.

Стеноз глотки и шейного отдела пищевода — пластика свободным сегментом кишки; субтотальное поражение глотки и пищевода — пластика пищевода толстой кишкой.

Протяжённые или множественные стриктуры — пластика пищевода с одномоментной или раздельной экстирпацией; выбор — за хирургами специализированных центров.

Дети с протяжёнными или множественными стенозами — колоэзофагопластика с загрудинным проведением трансплантата.

Протяжённые стриктуры без ожога желудка — резекция пищевода абдоминоцервикальным доступом с пластикой желудком.

Стеноз привратника — операция (задний гастроэнтероанастомоз с анастомозом по Брауну, резекция желудка не рекомендуется) или эндоскопическая баллонная дилатация.

Трахеопищеводное соустье без дыхательной недостаточности — сдерживающая тактика: лапароскопическая фундопликация, гастростомия, консервативная терапия; свищ закрывается в среднем **до 5 месяцев**.

Дети с большим соустьем и дыхательной недостаточностью — пластика трахеи пищеводным лоскутом с экстирпацией пищевода, пластика пищевода позже.

Аортопищеводная фистула — экстренная операция даже без видимого кровотечения.

Триада Киари

1. нарастающая загрудинная боль;
2. необильные периодические кровотечения;
3. массивное кровотечение после «светлого промежутка».

При кровотечении — зонд Блэкмора (пищеводный баллон на среднюю треть); клипирование ошибочно.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. клинико-анамнестические признаки химического ожога ЖКТ.

Выписка

1. нормализация общего состояния и анализов;
2. нет эрозивно-язвенного эзофагита при эндоскопии;
3. нет осложнений;
4. нормальный нутритивный статус, возможно энтеральное питание (естественное или через гастростому).

Ожог I степени — сразу кормить и выписать через **24–48 часов**: риска стриктуры нет.

Суицидальная попытка — перед выпиской осмотр психотерапевта; долгосрочное наблюдение.

5.2 Реабилитация

Реабилитация — как можно раньше, одновременно с лечением: индуктотермия, цинк-электрофорез, электрофорез органно-минерального комплекса, низкоинтенсивное лазерное излучение; после бужирования — магнитотерапия курсами 5–7 сеансов.

5.3 Диспансерное наблюдение

После выписки — хирург (детский хирург) поликлиники **3 года** от травмы.

Ожог III степени — плановая госпитализация для ЭГДС **через 1 месяц** после выписки, затем через 3 и 6 месяцев.

Нет признаков стриктуры — осмотр хирурга **каждые 6 месяцев**, всего **в течение 3 лет**; появилась дисфагия — госпитализация для ЭГДС. Рубцовая деформация без сужения — ЭГДС **каждые 3 года**: риск рака.

На догоспитальном этапе — подтвердить приём, определить вещество, причину и время. Нельзя: положение лёжа на спине, разбавители, нейтрализация — повторный ожог и аспирация. Лечение поздних последствий — в специализированных центрах.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Химический ожог пищевода»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 25.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	821_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальное общество торакальных хирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки глюкокортикоидов расходятся: при стенозе гортани — ожог I степени без глюкокортикоидов, II–III степени — 5–7 дней; для профилактики рубцового сужения — от 7 суток (лёгкий ожог) до не менее 30 суток (тяжёлый) с продолжением амбулаторно.

- Таблица Zargar в разделе 1.5 и в приложении А3 различается: степень IIB — «глубокие и циркулярные язвы» и «окружные поражения».